Retinopatías · Repaso en 10 minutos

Hoja final de recuperación. Úsala después de la guía y casos; comparte sus fuentes y criterios. Cubre la respuesta y dilo en voz alta.

1. La consulta en una frase

Alarmas → historia → agudeza visual por ojo y presión → fondo → estadio + mácula → estudios → tratamiento/referencia → alarmas y seguimiento.

Pregunta inicio súbito o gradual, lateralidad, dolor, destellos, moscas volantes y cortina; años de diabetes, HbA1c, HTA, riñón, tratamientos/adherencia, revisiones previas y embarazo si corresponde. Describe papila, vasos, mácula y retina visible. Fondo no valorable no significa normal.

2. No perder estas urgencias

- Pérdida súbita, cortina o nuevas miodesopsias/destellos: valoración urgente el mismo día. No esperar HbA1c ni OCT electiva.
- Pérdida monocular súbita intensa: considerar oclusión arterial; urgencias y evaluación vascular/ictus.
- Ojo rojo doloroso con pérdida visual: urgencias oftalmológicas.
- Presión muy elevada + lesión retiniana aguda u otro daño de órgano: urgencias hospitalarias. No esperar edema de papila ni normalizar presión bruscamente.

3. Las clasificaciones que debes decir sin leer

RD	Hallazgo
Leve	Solo microaneurismas
Moderada	Más lesiones, sin criterios de severa
Severa	Un criterio 4-2-1, sin proliferación
Proliferativa	Neovasos

4: >20 hemorragias en cada uno de cuatro cuadrantes. **2:** arrosariamiento venoso en ≥2. **1:** AMIR prominentes en ≥1. Basta uno; AMIR no equivale a neovasos.

Mácula = segundo eje: puede haber edema en cualquier estadio. Exudados cercanos + pérdida central hacen sospechar; OCT confirma engrosamiento y localización. Clasificar cada ojo.

RH, Keith-Wagener-Barker: I estrechamiento; II cruces/esclerosis; III hemorragias/exudados; IV añade edema de papila. La emergencia se decide por daño agudo y contexto, no solo por el grado.

4. Conducta y estudios

Situación	Respuesta
Todas las RD	Control glucemia, presión y riesgo cardiovascular; seguimiento ocular

Situación	Respuesta
RDNP moderada o peor, cualquier edema o RDP	Referir; priorizar amenaza visual
Proliferativa	Panfotocoagulación o anti-VEGF según especialista
Edema central con visión reducida	Anti-VEGF habitual
Hemorragia persistente/tracción	Especialista valora vitrectomía
RH crónica	Tratar HTA y riesgo sistémico

Primer nivel: HbA1c, función renal, albuminuria y lípidos según contexto. **OCT:** edema. **Ecografía:** fondo oculto por sangre/opacidad. **Angiografía:** especialista si necesita estudiar fuga/isquemia, no cribado rutinario.

5. Cribado y cierre

DM2: al diagnóstico. DM1 adulta: dentro de cinco años. Cualquier RD: al menos anual, antes si progresa. Sin RD en controles previos y buen control: puede considerarse 1–2 años. Diabetes pregestacional: antes/primer trimestre, vigilancia durante embarazo y posparto según gravedad. Gestacional aislada: no cribado por ese motivo.

Explica: «Puede haber daño aunque vea bien. El control y las revisiones protegen su visión. Una cortina, destellos nuevos o pérdida súbita requieren atención inmediata».

Referencia: inicio, agudeza por ojo, presión, lesiones/lateralidad, diagnóstico probable, prioridad, tratamiento y contacto. No confundir intervalo de seguimiento con plazo para conseguir valoración inicial.

Tres preguntas finales: ¿es urgente?, ¿hay neovasos?, ¿hay edema? Si no puedes responder, describe qué te falta y cómo lo vas a resolver.